I. Description

Parmi les femmes de 25 à 65 ans inclus (< 66 ans) à risque de développer un cancer du col de l'utérus, l'indicateur est validé pour celles ayant bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus :

- De 25 à 29 ans : par une analyse cytologique depuis 1 an ou moins, ou par deux analyses cytologiques espacées d'au moins 6 mois et dont la dernière date de 3 ans ou moins.
- De 30 à 65 ans : par un test HPV-HR depuis 5 ans ou moins.

Les femmes qui n'ont plus de col de l'utérus, qui ont ou ont eu un cancer de l'utérus, ou qui ont récemment bénéficié d'un acte à visée diagnostique ou thérapeutique sur le col de l'utérus, sont exclues de l'indicateur.

II. Critères de ciblage

1. Population cible

« *Parmi les femmes de 25 à 65 ans inclus (< 66 ans) […]* » :

- Sexe = Femme
  ET
- Age ≥ 25 ans ET < 66 ans

2. Critères d'exclusion

« *Les femmes qui n'ont plus de col de l'utérus, […]* » :

- Antécédent d'hystérectomie totale (codes CCAM = « **JKFA002** », « **JKFA004** », « **JKFA005** », « **JKFA006** », « **JKFA007** », « **JKFA013** », « **JKFA015** », « **JKFA018** », « **JKFA020** », « **JKFA021** », « **JKFA023** », « **JKFA025** », « **JKFA026** », « **JKFA027** », « **JKFA028** », « **JKFA030** », « **JKFC003** », « **JKFC005** », ou « **JKQX006** »)
- Antécédent de trachélectomie (codes CCAM = « **JKFA008** », « **JKFA009** », « **JKFA011** », ou « **JKFA019** »)

« *[…] qui ont ou ont eu un cancer de l'utérus, […]* » :

- ALD active ou antécédent de cancer du col de l'utérus (code CIM10 = « **C53*** »)
- ALD active ou antécédent de cancer du corps de l'utérus (code CIM10 = « **C54*** »)
- ALD active ou antécédent de cancer de l'utérus (code CIM10 = « **C55*** »)

« *[…] ou qui ont récemment bénéficié d'un acte à visée diagnostique ou thérapeutique sur le col de l'utérus, […]* » :

- Colposcopie (code CCAM = « **JLQE002** ») dans les 4 dernières années
- Conisation ou exérèse du col de l'utérus (codes CCAM = « **JKFA031** » ou « **JKQX007** ») dans les 4 dernières années
- Destruction ou exérèse de lésion du col de l'utérus (codes CCAM = « **JKND003** », « **JKND004** », « **JFKD002** », ou « **JKFE003** ») dans les 4 dernières années

3. Critères de réalisation de l'acte de prévention

« *[…] un dépistage du cancer du col de l'utérus : […]* » :

- Analyse cytologique des cellules du col sur prélèvement cervico-utérin (codes CCAM = « **JKQX001** », « **JKQX008** », « **JKQX015** », « **JKQX027** », « **JKQX147** », « **JKQX261** », « **JKQX347** », ou « **JKQX426** » ; codes NABM = « **0013** », « **0026** », « **0027** », « **0028** », « **0029** », « **0030** », « **0032** », ou « **0033** ») dans les 12 derniers mois (à condition que l'acte ait été réalisé entre 24 ans ½ et 30 ans ½ inclus) ;
  OU
- Deux analyses cytologiques des cellules du col sur prélèvement cervico-utérin (codes CCAM = « **JKQX001** », « **JKQX008** », « **JKQX015** », « **JKQX027** », « **JKQX147** », « **JKQX261** », « **JKQX347** », ou « **JKQX426** » ; codes NABM = « **0013** », « **0026** », « **0027** », « **0028** », « **0029** », « **0030** », « **0032** », ou « **0033** ») dans les 36 derniers mois (à condition que les deux actes aient été réalisé entre 24 ans ½ et 30 ans ½ inclus, et à au moins 6 mois d'intervalle l'un de l'autre) ;
  OU
- Test HPV-HR sur prélèvement cervico-utérin (codes CCAM = « **ZZQX173** », « **ZZQX603** », ou « **ZZQX628** » ; codes NABM = « **4127** », « **4509** », « **0024** », ou « **0031** ») dans les 5 dernières années (à condition que l'acte ait été réalisé à partir de 30 ans)

III. Modalités de rémunération (FMT – Majoration Prévention)

Pour chaque patiente « médecin traitant » de 25 à 65 ans au 31/12 de l'année N (à l'exclusion des patientes ayant un motif d'exclusion), le médecin est rémunéré si la patiente a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus par une analyse cytologique entre le 01/01 et le 31/12 de l'année N, ou par deux analyses cytologiques (réalisées à au moins 6 mois d'intervalle l'une de l'autre) dont la dernière a été réalisée entre le 01/01 de l'année N-2 et le 31/12 de l'année N, ou par un test HPV-HR entre le 01/01 de l'année N-4 et le 31/12 de l'année N.

Seules les analyses cytologiques des cellules du col sur prélèvement cervico-utérin réalisées entre 24 ans ½ et 30 ans ½ sont prises en compte.

Seuls les tests HPV-HR sur prélèvement cervico-utérin réalisés à compter de 30 ans sont pris en compte.

IV. Explications complémentaires

1. Argumentaire

L'objectif de cet indicateur est de permettre au médecin traitant de suivre l'adhésion au programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus parmi ses patientes éligibles à ce dépistage organisé, c'est-à-dire parmi ses patientes à risque de développer un cancer du col de l'utérus.

Conformément aux recommandations en vigueur, le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus dépend de l'âge. Entre 25 et 29 ans, il repose sur la réalisation de deux analyses cytologiques à 1 an d'intervalle, puis une nouvelle analyse cytologique tous les 3 ans. À partir de 30 ans, il repose sur la réalisation d'un test HPV-HR tous les 5 ans. Autrement dit, une

femme éligible est considérée comme « à jour » dès lors qu'elle a bénéficié d'une analyse cytologique depuis 1 an ou moins, ou de deux analyses cytologiques espacées d'au moins 1 an et dont la dernière date de 3 ans ou moins, ou d'un test HPV-HR depuis 5 ans ou moins, en ne prenant en compte que les analyses cytologiques réalisées entre 25 et 29 ans inclus, et que les tests HPV-HR réalisés à partir de 30 ans. Afin de tenir compte de la complexité du schéma de dépistage recommandé en fonction de l'âge, les contraintes portant sur les âges de réalisation des analyses cytologiques sont « assouplies » de 6 mois, tout comme la contrainte portant sur l'intervalle de temps entre la réalisation des deux premières analyses cytologiques.

Le ciblage de la population éligible, c'est-à-dire des femmes à risque de développer un cancer du col de l'utérus, s'appuie sur les recommandations de la HAS. Il s'agit de toutes les femmes de 25 à 65 ans, à l'exclusion de celles qui se trouvent dans les situations suivantes :

- Les femmes qui n'ont plus de col de l'utérus, et qui ne peuvent donc plus développer de cancer du col ;
- Les femmes qui ont ou ont eu un cancer de l'utérus, qui relèvent d'une stratégie de suivi individuel adaptée ;
- Les femmes qui ont récemment bénéficié d'un acte à visée diagnostique ou thérapeutique sur le col de l'utérus, qui sont exclues temporairement du dépistage organisé ;
- Les femmes qui ont signalé à l'assurance maladie un motif d'exclusion du dépistage organisé du col de l'utérus (motif parmi ceux précités).

2. Documents de référence

L'indicateur s'appuie sur les documents suivants :

- Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049025564
- INCa : https://www.cancer.fr/catalogue-des-publications/referentiel-national-types-et-contenus-des-fichiers-necessaires-a-la-creation-des-bases-de-donnees-pour-le-depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus
- HAS : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3192618/fr/depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus-le-test-hpv-hr-recommande-chez-les-femmes-de-plus-de-30-ans

3. Limites

Ces indicateurs de prévention sont calculés à partir des données de remboursement de l'assurance maladie, qui ont l'avantage de couvrir l'ensemble de la population assurée, tous régimes confondus.

Cependant, par construction, elles ne retracent que les soins qui ont fait l'objet d'une facturation à l'assurance maladie.

Tout acte ou prestation réalisé hors de ce circuit ne sera pas pris en compte dans le calcul, et en particulier :

- Les soins réalisés à l'étranger ;
- Les soins prodigués au sein de certaines structures qui ne facturent pas à l'assurance maladie (médecine du travail, PMI, médecine scolaire ou universitaire, etc.) ;
- Certains soins sans codage spécifique prodigués lors d'un séjour en établissement (actes cliniques, certains actes techniques ou de biologie financés dans le cadre du séjour, médicaments délivrés par la pharmacie interne de l'établissement, etc.).

De même, les informations contenues dans le dossier médical du patient, y compris les résultats d'examen, et y compris les documents stockés dans son dossier médical partagé ou dans « Mon Espace Santé », ne seront pas prises en compte dans le calcul.

Par ailleurs, certains professionnels ou certaines structures de soins peuvent facturer les soins réalisés de façon différée (à une date ultérieure) : cela ne fausse pas la date de réalisation du soin, mais il faudra alors attendre que l'acte ait été effectivement remboursé pour qu'il puisse être pris en compte dans le calcul.

Enfin, indépendamment du délai de facturation de l'acte par le professionnel, il existe aussi un certain délai pour que l'information soit traitée et mise à disposition, et qu'elle puisse ainsi être prise en compte dans le calcul.

En pratique, pour toutes ces raisons, il peut y avoir un écart entre les données restituées et la situation réelle du patient à un instant donné. Pour cet indicateur, les principales situations susceptibles d'entrainer de tels écarts sont les suivantes :

a. Population cible

- Risque d'écart négligeable ;

b. Critères d'exclusion

- Cancer du col ou du corps de l'utérus diagnostiqué mais sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée, et sans que ce diagnostic n'ait été codé lors d'un quelconque séjour en établissement ;
- Acte à visée diagnostique ou thérapeutique sur le col de l'utérus réalisé dans le cadre d'un séjour en établissement, sans codage spécifique de l'acte.

c. Critères de réalisation de l'acte de prévention

- Analyse cytologique ou test HPV-HR réalisé(e) sur prélèvement cervico-utérin dans le cadre d'un séjour en établissement, sans codage spécifique de l'acte.

V. Précisions techniques

Source : SNIIRAM

Champ de la requête : tous régimes – patients ayant un médecin traitant

Profondeur de la requête par rapport à la date de référence de la photo :

- Pour définir la population cible : aucune profondeur (sexe et âge uniquement)
- Pour les critères d'exclusion à prendre en compte : profondeur maximale disponible
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour valider l'indicateur : 60 mois
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour l'affichage : 1er jour du mois du 24ème anniversaire ½

Composants utilisés pour la requête :

- ✓ DCIR → tables de consommation de soins de ville qui permet de repérer les actes et prestations générales (codes NGAP ou autres codes de facturation), les actes techniques (codes CCAM), les actes de biologie (codes NABM), ou la délivrances de médicament (codes CIP ou classes ATC) ; les soins facturés au cours d'un mois donné sont disponibles au début du mois suivant pour les assurés du régime général, et à la fin du mois suivant pour les assurés affiliés aux autres régimes (notamment MSA).
- ✓ IR_IMB_R → table du référentiel médicalisé qui permet d'identifier, en cas d'exonération du ticket modérateur (dont ALD), la pathologie précise (CIM10) associée.

- ✓ PMSI → tables relatives aux soins et pathologies précises (CIM10) associées aux séjours réalisés dans les établissements de santé publics et privés ; les soins et séjours au cours d'une année sont disponibles à la fin du 1er semestre de l'année suivante.
- × SSU → données relatives aux formulaires d'exclusion des programmes nationaux de dépistages organisés des cancer ; ces formulaires sont fournis aux assurés pour qu'ils puissent signaler à l'assurance maladie un ou plusieurs motif(s) d'exclusion dont elle n'aurait pas connaissance.

VI. Acronymes

ALD : affections de longue durée

ATC : *anatomical therapeutic chemical* → système international de classification des médicaments, permettant de regrouper plusieurs médicaments par classe thérapeutique

CCAM : classification commune des actes médicaux

CIM10 : classification internationale des maladies, version 10

CIP : code identifiant de présentation → code permettant d'identifier un médicament précis

DCIR : datamart de consommation inter-régime

IR_IMB_R : table du référentiel médicalisé

MSA : mutuelle sociale agricole

NABM : nomenclature des actes de biologie médicale

NGAP : nomenclature générale des actes professionnels

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d'information

PMI : protection maternelle et infantile → service départemental chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant

SNIIRAM : système national d'information inter-régime de l'assurance maladie